

Vessie hyperactive (OAB)

WARWIKI

Information pour le patient · Comprendre les urgences, la fréquence et les fuites

La vessie hyperactive, ou OAB, est une affection fréquente et traitable dans laquelle le muscle vésical se contracte au mauvais moment. Cela provoque un **besoin urgent et soudain d'uriner**, des mictions fréquentes, des réveils nocturnes et parfois des fuites avant d'atteindre les toilettes. Ce n'est **pas** un signe normal du vieillissement, et de nombreuses options permettent de l'améliorer.

À propos de cette affection

Normalement, la vessie se remplit calmement et vous avertit quand elle est presque pleine. Avec l'OAB, elle envoie un signal "urgent" trop tôt ou trop fortement. Les principaux symptômes sont :

- **Urgenturie** — un besoin soudain et difficile à retenir d'uriner
- **Pollakiurie** — plus de 8 mictions environ par jour
- **Nycturie** — se réveiller la nuit pour uriner
- **Fuite par urgenturie** — parfois une fuite en allant aux toilettes

Causes

Souvent, il n'y a pas de cause unique — c'est un problème de signaux entre la vessie et le cerveau. Les facteurs qui peuvent déclencher ou aggraver l'OAB comprennent la **caféine et l'alcool**, la constipation, le surpoids, certains médicaments et, chez la femme, la ménopause. Une infection urinaire peut provoquer les mêmes symptômes : elle est donc vérifiée en premier. Parfois, une atteinte nerveuse est en cause.

COMPRENDRE LES TERMES

Vessie hyperactive (OAB)

Urgenturie et mictions fréquentes dues à une contraction prématurée de la vessie.

Urgenturie

Besoin soudain et fort d'uriner, difficile à différer.

Pollakiurie

Besoin d'uriner de nombreuses fois dans la journée.

Nycturie

Se réveiller pendant la nuit pour uriner.

Incontinence par urgenturie

Fuite d'urine accompagnant un besoin urgent.

Calendrier mictionnel

Journal simple des boissons, mictions et fuites.

Plancher pelvien

Les muscles que vous pouvez renforcer pour mieux contrôler la vessie.

Rééducation vésicale

Allonger progressivement les intervalles entre les mictions pour calmer l'urgenturie.

EST-CE QUE ÇA VA S'AMÉLIORER ? Oui — la plupart des personnes s'améliorent. Le traitement commence généralement par des changements simples et la rééducation vésicale, et n'est intensifié que si nécessaire. Quelques semaines peuvent être nécessaires avant de constater une différence : accordez du temps à chaque étape et continuez à travailler avec votre équipe soignante.

Comment on le diagnostique

- Un entretien sur vos symptômes et un **calendrier mictionnel**
- Un **examen d'urine** pour écarter une infection ou la présence de sang
- Une vérification de la vidange vésicale (échographie rapide)
- Parfois des examens complémentaires (bilan urodynamique ou cystoscopie) si le tableau est incertain ou si les premiers traitements ont échoué

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Mode de vie & rééducation** — réduire la caféine et l'alcool, gérer les apports en liquides, traiter la constipation, perdre l'excès de poids, et pratiquer la **rééducation vésicale** et les **exercices du plancher pelvien**.
- 2 **Médicaments** — comprimés qui calment le muscle vésical.
- 3 **Options avancées** — injections de **Botox** dans la vessie ou **neurostimulation** (PTNS ou neuromodulation sacrée). Chacune dispose de sa propre fiche d'information.

Vivre avec l'OAB

- Tenez un **calendrier mictionnel** quelques jours pour repérer les facteurs déclenchants.
- Buvez régulièrement ; ne réduisez pas trop les liquides au risque de concentrer les urines.
- Utilisez les **mictions programmées** et les techniques de "contrôle de l'urgenterie" (s'arrêter, contracter le plancher pelvien, respirer, puis aller aux toilettes) que votre équipe soignante vous enseigne.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Du sang dans les urines**, ou une douleur ou brûlure à la miction
- De la fièvre ou une douleur dans le dos ou les flancs (possible infection)
- Une incapacité soudaine à **uriner**

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'OAB — urgenterie, pollakiurie, réveils nocturnes et parfois fuites — est fréquente et traitable ; ce n'est pas un signe normal du vieillissement.
2. Le traitement progresse par étapes : mode de vie et rééducation vésicale en premier, puis médicaments, puis Botox ou neurostimulation.
3. Un calendrier mictionnel aide à repérer les déclencheurs ; accordez quelques semaines à chaque étape. Appelez pour tout sang dans les urines, douleur, fièvre ou incapacité à uriner.